

CAPÍTULO 13.14

Absceso pulmonar

PERFIL EUNACOM 1.04.1.024

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Definición

El **absceso pulmonar** se define como una lesión necrótica localizada en el parénquima pulmonar que contiene material purulento, habitualmente resultado de una infección bacteriana. A diferencia de la **Neumonía** común, el absceso implica la formación de una cavidad con un nivel hidroaéreo, lo que marca una diferencia tanto en su evolución clínica como en su abordaje terapéutico.

Es fundamental que el médico general sepa identificarlo, ya que su curso suele ser más larvado y requiere una cobertura antibiótica específica para gérmenes **anaerobios**, además de una vigilancia estrecha ante la necesidad de drenaje.

Cuadro Clínico

La presentación clásica del absceso pulmonar dista de la agudeza de una neumonía neumocócica típica. Se caracteriza por:

- **Inicio insidioso:** El cuadro suele evolucionar de forma lenta, durante varias semanas o incluso meses.
- **Síntomas generales (Síntomas B):** Es muy frecuente encontrar fiebre persistente, baja de peso significativa y sudoración nocturna.
- **Síntomas respiratorios:** Tos productiva que puede haber comenzado como una neumonía común y corriente que no resolvió adecuadamente.
- **Expectoración pútrida o fétida:** Este es el signo clínico más característico y de mayor valor orientador. La presencia de mal olor en el esputo sugiere fuertemente la presencia de **bacterias anaerobias**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un paciente presenta un cuadro respiratorio de semanas de evolución con **expectoración fétida**, la sospecha principal debe ser un **absceso pulmonar**. Esto permite diferenciarlo de otras causas de cuadros crónicos como la **Tuberculosis** o el **Cáncer de Pulmón**.

Factores de Riesgo y Patogenia

NOTA CLÍNICA

La mayoría de los abscesos pulmonares son consecuencia de una **aspiración** de contenido orofaríngeo. Por esta razón, los gérmenes involucrados suelen ser parte de la microbiota oral, predominantemente anaerobios (como *Peptostreptococcus*, *Fusobacterium* y *Bacteroides*).

- Los factores que predisponen a la formación de un absceso incluyen:
- **Trastornos de la deglución o del nivel de conciencia:** Alcoholismo, crisis epilépticas, accidentes cerebrovasculares o anestesia general.
- **Mala higiene dental:** La enfermedad periodontal aumenta la carga de anaerobios en la orofaringe.
- **Obstrucción bronquial:** Un tumor endobronquial puede causar una neumonía obstructiva que termine abscedándose.
- **Inmunosupresión:** Pacientes con VIH o en quimioterapia pueden desarrollar abscesos por gérmenes oportunistas.

Diagnóstico por Imágenes

El diagnóstico se sospecha clínicamente, pero se confirma mediante estudios de imagen.

Radiografía de Tórax

Es el examen inicial. Los hallazgos típicos son: - Una cavidad con una **pared gruesa** e irregular. - Presencia de un **nivel hidroaéreo** (una línea horizontal que separa el contenido líquido/pus de la parte superior gaseosa/aire).

Tomografía Axial Computarizada (TAC)

Una vez identificado el absceso en la radiografía, el TAC de tórax es imperativo para: 1. **Delimitar la lesión:** Conocer con exactitud su ubicación anatómica. 2. **Diferenciarlo de un empiema:** Es vital distinguir si la colección está dentro del pulmón (absceso) o en el espacio pleural (empiema), ya que el manejo del empiema siempre requiere drenaje quirúrgico inmediato. 3. **Planificar el abordaje:** En caso de que se requiera un drenaje percutáneo o broncoscópico.

TABLA 13.14.1: HALLAZGO VS ABSCESO PULMONAR

HALLAZGO	ABSCESO PULMONAR	EMPIEMA PLEURAL
Forma	Redondeada	Lenticular (forma de lente)
Nivel Hidroaéreo	Igual longitud en proyecciones AP y Lateral	Longitud distinta según la proyección
Ángulo con la pared	Ángulo agudo	Ángulo obtuso
Vasos pulmonares	Interrumpidos por la lesión	Desplazados por la lesión

Diagnóstico Diferencial

- Dada su presentación crónica y la presencia de cavitaciones, se debe diferenciar de:
- **Tuberculosis** (especialmente si hay compromiso de los lóbulos superiores).
- **Carcinoma bronquial cavitado:** Un cáncer que se necrosa en su centro puede imitar un absceso.
- **Granulomatosis con poliangeítis (Wegener):** Causa nódulos cavitados.
- **Quiste hidatídico complicado:** Frecuente en zonas endémicas de Chile.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En pacientes fumadores de edad avanzada que presentan un "absceso" sin una causa clara de aspiración, siempre se debe descartar un **cáncer de pulmón subyacente** mediante **Broncoscopia** o seguimiento estricto tras el tratamiento antibiótico.

Tratamiento y Manejo

El manejo del absceso pulmonar se basa en tres pilares: antibióticos, quinesioterapia y, en casos seleccionados, drenaje.

1. Antibioticoterapia

El tratamiento debe ser prolongado (habitualmente de 4 a 6 semanas o hasta que la radiografía muestre resolución o una pequeña cicatriz estable). Debe cubrir gérmenes anaerobios y estreptococos.

TABLA 13.14.2: OPCIÓN VS FÁRMACO(S)

OPCIÓN	FÁRMACO(S)	NOTAS
Elección clásica	Clindamicina	Excelente penetración pulmonar y cobertura de anaerobios.
Alternativa	Amoxicilina + Ácido Clavulánico	Muy utilizada por su comodidad oral.
Otras opciones	Moxifloxacino	Útil en pacientes alérgicos a penicilina.
Combinación	Ceftriaxona + Metronidazol	Cobertura amplia para pacientes hospitalizados.

2. Quinesioterapia Respiratoria (KTR)

Es fundamental para favorecer el **drenaje postural** del absceso. Ayuda a que el paciente elimine el contenido purulento a través de la vía aérea de forma espontánea.

3. Drenaje

La mayoría de los abscesos drenan espontáneamente a través del árbol bronquial. Sin embargo, se debe considerar el drenaje intervencionista si: - El absceso es de gran tamaño (> 6 cm). - No hay respuesta clínica tras 7-10 días de antibióticos. - Hay sospecha de neoplasia obstructiva.

- Existen dos vías principales de drenaje, ambas con efectividad similar según la experiencia del centro:
- **Drenaje Trastorácico:** Realizado mediante punción percutánea guiada por ecografía o TAC.
- **Drenaje Transbronquial:** Realizado mediante **Broncoscopia**.

EUNACOM CRITERIOS

El absceso pulmonar es una patología de manejo especialista. Ante la sospecha clínica y radiológica, se debe iniciar el tratamiento antibiótico y **derivar al broncopulmonar** para completar el estudio y seguimiento.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 55 años, alcohólico crónico, consulta por tos con expectoración fétida de 3 semanas de evolución, fiebre y baja de peso. La radiografía de tórax muestra una imagen con nivel hidroaéreo en lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Absceso pulmonar. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El absceso pulmonar tiene un curso insidioso de semanas a meses, a diferencia de la neumonía aguda
- La expectoración pútrida o fétida es el elemento clínico más orientador del absceso pulmonar
- Las neumonías aspirativas son las que más frecuentemente se abscedan
- Los síntomas B (fiebre, baja de peso, sudoración nocturna) son frecuentes pero inespecíficos
- En la radiografía se observa un nivel hidroaéreo de pus con pared alrededor
- El TAC complementa el diagnóstico para delimitar la lesión y planificar el drenaje
- El antibiótico de elección es clindamicina por su cobertura de anaerobios
- Alternativas: amoxicilina/ácido clavulánico, metronidazol o moxifloxacino
- El drenaje puede ser transtorácico (por punción) o transbronquial (por broncoscopia), ambos equivalentes

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ABSCESO PULMONAR)

PREGUNTA 1

Paciente de 55 años, alcohólico crónico, consulta por tos con expectoración fétida de 3 semanas de evolución, fiebre y baja de peso. La radiografía de tórax muestra una imagen con nivel hidroaéreo en lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Neumonía adquirida en la comunidad
- ☐ B) Tuberculosis pulmonar
- ☐ C) Absceso pulmonar
- ☐ D) Cáncer pulmonar
- ☐ E) Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*

PREGUNTA 2

¿Cuál es el antibiótico de primera elección en el tratamiento del absceso pulmonar?

- ☐ A) Amoxicilina
- ☐ B) Azitromicina
- ☐ C) Ceftriaxona
- ☐ D) Clindamicina
- ☐ E) Levofloxacino

PREGUNTA 3

Respecto al absceso pulmonar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ A) El drenaje transtorácico es claramente superior al transbronquial
- ☐ B) El curso clínico es habitualmente agudo, de pocos días de evolución
- ☐ C) La expectoración pútrida es el elemento clínico más orientador
- ☐ D) El tratamiento es exclusivamente quirúrgico
- ☐ E) La radiografía de tórax muestra cavitaciones sin nivel hidroaéreo

RESUMEN: ABSCESO PULMONAR

El absceso pulmonar es una complicación infecciosa que se diferencia de las neumonías comunes por su presentación clínica y manejo. Se caracteriza por un inicio lento e insidioso, con un curso de semanas a meses, a diferencia de la neumonía aguda. Los síntomas son similares a los de una neumonía, y de hecho puede comenzar como una neumonía común que luego se absceda, pero lo más frecuente es un curso larvado. El elemento clínico más orientador es la expectoración pútrida o fétida, que diferencia al absceso de otras causas de cuadro pulmonar crónico como la tuberculosis o la neumonía por *Pneumocystis jirovecii*. El antecedente de aspiración también orienta al diagnóstico, ya que las neumonías aspirativas son las que más frecuentemente se abscedan. Los síntomas B (fiebre, baja de peso, sudoración nocturna) son frecuentes pero inespecíficos. El diagnóstico se realiza con radiografía de tórax, donde se observa un nivel hidroaéreo de pus con una pared alrededor. Luego se complementa con TAC para delimitar la lesión y planificar el drenaje. El tratamiento incluye antibióticos con cobertura de anaerobios (clindamicina como primera elección, o amoxicilina/ácido clavulánico, metronidazol, moxifloxacino), kinesioterapia respiratoria para facilitar el drenaje, y drenaje por punción transtorácica o por broncoscopia transbronquial, según la experiencia del equipo tratante.